Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Santa Maria da Boa Vista

R PROF. RAIMUNDO COIMBRA FILHO, 131, Forum da Comarca de Santa Maria da Boa Vista - Sem Denominação, Sen. Paulo Pessoa Guerra, STA MARIA B VISTA - PE - CEP: 56380-000 - F:(87) 38693655

Processo nº 0020320-08.2024.8.17.3130

AUTOR(A): MARIA JOSE DE ASSUNCAO MEDRADO

RÉU: UNIAO, ESTADO DE PERNAMBUCO, PGE - 2ª PROCURADORIA REGIONAL - PETROLINA, UNIÃO FEDERAL

SENTENÇA

RELATÓRIO

A parte autora**,** devidamente qualificada, ajuizou a presente ação Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA JOSE DE ASSUNCAO MEDRADO em face do ESTADO DE PERNAMBUCO e da UNIÃO, objetivando o fornecimento do medicamento TERIPARATIDA (FORTEO), na posologia de 20mcg por dia, pelo período de 24 meses.

A autora narra que é idosa de 86 anos de idade e portadora de osteoporose pós-menopausa com fratura patológica, classificada sob o código CID-10 M80.1. Relata que possui histórico de câncer de mama e que, há mais de uma década, vem realizando tratamento para osteoporose por meio de múltiplos medicamentos bisfosfonados orais, tais como Alendronato, Ibandronato e Risedronato, além de suplementação com cálcio e vitamina D, todos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Aduz que, não obstante o tratamento regular ao longo dos anos, sofreu em agosto de 2023 fratura de fragilidade em úmero proximal direito, decorrente de queda da própria altura, e que evoluiu com perda progressiva de massa óssea, apresentando índices de osteoporose severa com T-score inferior a -3,0. Afirma que o quadro clínico caracteriza falha terapêutica aos medicamentos anteriormente utilizados e que possui risco muito alto de novas fraturas, com potencial para eventos graves e fatais, tais como fratura de fêmur, trombose, embolia pulmonar e óbito.

Informa que lhe foi prescrito, em caráter emergencial, tratamento com o medicamento TERIPARATIDA (FORTEO), na dose de 20mcg diários, durante o período de 24 meses, e que não possui condições financeiras para custear o tratamento, cujo valor foi estimado em R$ 117.374,88 para o período completo.

Em decisão proferida em 03 de dezembro de 2024, foi **deferido o pedido de tutela de urgência** e determinou que o Estado de Pernambuco fornecesse o medicamento TERIPARATIDA FORTEO, limitando a decisão ao primeiro ciclo de tratamento. Na mesma decisão, **o Juízo excluiu a União do polo passivo da demanda**, com fundamento no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, e deixou de fixar multa cominatória, anunciando que, em caso de descumprimento, procederia ao bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

Regularmente citado, o ESTADO DE PERNAMBUCO apresentou contestação arguindo preliminares e impugnando o mérito da pretensão. Em sede de preliminar, suscita a incorreção do valor da causa, sustentando que, por se tratar de obrigação de fazer sem conteúdo econômico direto para a autora, o valor deveria ser simbólico de R$ 1.000,00 e não o custo total do medicamento, o que impactaria a base de cálculo de eventuais honorários advocatícios. Arguiu ainda a ausência de interesse de agir, argumentando que a autora não comprovou ter realizado pedido administrativo prévio para o fornecimento do medicamento, não havendo, portanto, negativa ou resistência por parte da administração pública que justificasse a intervenção do Poder Judiciário.

No mérito, alega que o medicamento TERIPARATIDA é dispensado pelo programa Farmácia de Pernambuco para a patologia da autora e que a requerente deve seguir os trâmites burocráticos necessários para sua obtenção. Postula que, em caso de procedência, a entrega do fármaco seja condicionada à apresentação periódica de laudos, receitas e laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Argumenta pela desnecessidade de multa diária, sugerindo que seja concedido prazo razoável para cumprimento, e requer a solicitação de parecer técnico ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Em petição posterior à contestação, o Estado de Pernambuco informa que realizou diligência junto à Secretaria de Saúde e confirma que o medicamento é dispensado pelo programa Farmácia de Pernambuco para a patologia da autora, mas esclarece que não houve pedido administrativo prévio por parte da requerente.

A autora apresentou réplica à contestação refutando as preliminares arguidas. Quanto à incorreção do valor da causa, sustenta que este foi calculado corretamente com base no custo estimado da providência pretendida, conforme artigos 291 a 293 do Código de Processo Civil. Em relação à ausência de interesse de agir, contrapõe que o direito fundamental à saúde e o acesso à justiça não podem ser condicionados ao esgotamento da via administrativa, especialmente diante da urgência e da hipossuficiência da autora. Informa que, após tomar conhecimento da via administrativa pela contestação do réu, deu início ao procedimento de solicitação junto à Farmácia de Pernambuco e anexa os documentos comprobatórios do pedido datados de março de 2025. Reitera a urgência do caso e a necessidade de manutenção da liminar e da multa, considerando o risco de morte. Ao final, requer a rejeição de todos os motivos alegados na contestação e a procedência de todos os pedidos formulados na petição inicial.

É o relatório. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de hipótese característica de julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é exclusivamente de direito e os fatos estão documentalmente comprovados. O feito, portanto, encontra-se em condições de ser sentenciado (art. 355, I do CPC).

Considerando que o tema que permeia o presente feito já foi amplamente debatido no âmbito dos Tribunais Superiores, passo ao julgamento à luz dos precedentes qualificados.

Antes, contudo, é necessário enfrentar as questões preliminares.

Da adequação do valor da causa

A preliminar de incorreção do valor da causa não merece acolhida.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 292, inciso V, que o valor da causa, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, será o valor da obrigação. Nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou insumos de saúde, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores

orienta que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, ou seja, ao custo estimado do tratamento objeto da ação.

No presente caso, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 117.374,88, correspondente ao custo estimado do medicamento TERIPARATIDA (FORTEO) pelo período de 24 meses, conforme prescrição médica. Trata-se de quantificação adequada e que reflete o proveito econômico buscado com a demanda, ainda que a obrigação seja de fazer e não importe em pagamento direto à parte autora.

A tese de que o valor deveria ser meramente simbólico não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência dominante. O valor da causa tem múltiplas funções no processo, incluindo a fixação de custas, a determinação de competência em razão do valor e a base de cálculo dos honorários advocatícios. Fixar valor simbólico em demandas desta natureza esvaziaria tais funções e não guardaria correspondência com a realidade econômica da prestação jurisdicional.

Ademais, o próprio Estado de Pernambuco não questiona a correção do montante indicado como custo do tratamento, limitando-se a argumentar que o valor deveria ser simbólico em razão da natureza da obrigação. Tal argumento não prospera.

Rejeito, pois, a preliminar de incorreção do valor da causa.

Da desnecessidade de esgotamento da via administrativa

A preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na falta de prévio requerimento administrativo, também não prospera.

O acesso à jurisdição é direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito, independentemente de prévio esgotamento da via administrativa. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação configuraria indevida restrição ao acesso à justiça, em frontal violação ao texto constitucional.

Da Inexistência De Violação Ao Princípio Da Separação Dos Poderes

É de bom alvitre frisar que, dentre outras missões, cabe ao Poder Judiciário atuar no sentido de efetivar os direitos fundamentais, sobretudo aqueles que se encontram assegurados na expressamente no texto Constitucional. Em decorrência disso é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Superior de Justiça, é firme no sentido de que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito fundamental à saúde. Nesse sentido:

> **Tema 793, da Repercussão Geral do STF**
>
> Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Da pretensão autoral

Do esboço normativo atinente a matéria, notadamente a firmação constitucional do direito à saúde, tido como direito de todos, sendo ainda uma obrigação por parte do poder público (art. 196 da CF), somado a disciplina infraconstitucional, conclui-se que o estado não pode eximir-se de prestar assistência médica e quem dele precise.

Porém, o poder público infirma a pretensão autoral, sob a justificativa de que os fármacos solicitados não estão elencados entre os disponíveis pela administração da saúde.

Neste ponto, o Tribunal de Justiça de Pernambuco há tempo já tinha firmado entendimento sobre o tema, o qual foi inclusive objeto de súmula, que ora transcrevo:

> **Súmula 018 - TJPE**. É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial

Não obstante isso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS):

> **Tema Repetitivo 106, do STJ**
>
> A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
>
> i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
>
> ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
>
> iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na mesma linha segue o Supremo Tribunal Federal:

> **Tema 500 da Repercussão Geral do STF**
>
> 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
>
> 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
>
> 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:
>
> (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

(iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Cumpre ainda destacar que o Supremo Tribunal Federal finalizou, no dia 13/09/2024, o julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral:

Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF

I – Competência

Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos **não incorporados na política pública do SUS, <u>mas com registro na ANVISA</u>**, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for **igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos**, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) **Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero)**.

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no **tema 500 da sistemática da repercussão geral**, é **mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos <u>sem registro na Anvisa</u>**, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146 de 28.11.2023, do CNJ. **Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor**.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, **deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo**

ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) **A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação** e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) **Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS**.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, **unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise**.

V –Plataforma Nacional

5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI –Medicamentos incorporados

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão"

(STF. Plenário. RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgado 13/09/2024 – Tema 1234 de Repercussão Geral)

Em tempo, também merece destaque a recente edição da Súmula vinculante nº 60, que assim dispõe:

Súmula vinculante nº 60

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Partindo para a análise do caso concreto, verifico que estão reunidas as condições estabelecidas pela jurisprudência qualificada para compelir o Poder Público a fornecer o tratamento vindicado na exordial.

Em pesquisa à RENAME/2022 (https://bvsms.saude.gov.br/publicada-a-relacao-nacional-de-medicamentos-rename-2022/) e ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/), constatei que:

* *TERIPARATIDA FORTEO 250 MCG /ML SOL INJ CT CARP VD INC X 2,4 ML X SIST APLIC PLAS – Registro Anvisa sob o nº 1126000790023.*

* *Apesar do medicamento não constar na RENAME, a CONITEC aprovou a incorporação no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, da teriparatida para o tratamento de indivíduos com osteoporose grave e falha terapêutica aos medicamentos disponíveis no SUS, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - vide PORTARIA SCTIE/MS Nº 62, DE 19 DE JULHO DE 2022*

Outrossim, da análise da contestação ID 193381557, verifico que o Estado de Pernambuco informa que dispensa regularmente o medicamento, o que reforça a conclusão acima alcançada e permite concluir, sem sombra de dúvidas, que a prestação pretendida pela autora é, de fato, devida.

Com isso, o autor preenche todos os requisitos exigidos pela lei e pela atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, fazendo jus a sua pretensão, a qual o poder público não pode eximir-se.

Da Reserva do Possível

Se isso não bastasse, é válido repisar que a garantia pelo Poder Público do direito fundamental em apreço, por se vincular à proteção do direito à vida, não se submete à cláusula da reserva do possível e traduz, isso sim, um impostergável dever de todos os entes da Federação, como já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal:

> AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Esta corte já firmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer, em juízo, a implementação de políticas públicas por parte do poder executivo de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. A Administração não pode invocar a cláusula da "reserva do possível" a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de insuficiência orçamentária. 4. Agravo regimental não provido.” (grifo acrescido)
>
> (STF; AI-AgR 674.764; 1ª Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 04.10.2011; DJE 25.10.2011; Pág. 23)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão formulada na inicial, para **CONDENAR** o Estado de Pernambuco, a fornecer o tratamento de saúde vindicado pela parte autora.

Duração do fornecimentos: o fornecimento deverá perdurar pelo tempo necessário à cura da enfermidade, ou não sendo esta possível, enquanto for possível a estabilização.

Obrigação imposta à parte autora: para continuar fazendo jus ao recebimento do tratamento, a parte autora **deverá apresentar diretamente aos entes públicos demandados, no máximo, a cada 6 meses**, laudos e/ou receituários médicos, informando acerca da necessidade de continuar o tratamento.

Neste ponto, destaco que é ônus da autora comprovar que cumpriu esta determinação, caso futuramente alegue negativa de fornecimento do tratamento.

<u>Da tutela de urgência</u> – com esteio no art. 300 do CPC, especialmente a urgência que o caso requer, devido ao risco de comprometimento da saúde da parte autora, **DEFIRO/CONFIRMO** o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a dispensação do tratamento, na forma acima delineada. **Deixo de fixar *astreintes***, tendo em vista que a prática forense evidencia que o meio mais adequado para assegurar a efetividade dos comandos judiciais envolvendo o acesso à saúde, é a **realização imediata de bloqueios através do SISBAJUD, o que anuncio desde logo que ocorrerá, em caso de descumprimento**.

Sem custas processuais, face a isenção do Estado de Pernambuco.

Fixo honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Outrossim, em sendo interposto recurso de apelação em face desta decisão, intime-se o apelado, através de seu patrono, para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de o apelado interpor apelação adesiva, intime-se o apelante, através de seu patrono, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as determinações retromencionadas, remetam-se os autos ao TJPE, para processamento do (s) recurso (s) interposto (s), independentemente de juízo de admissibilidade, nos moldes do artigo 1.010, §3º do NCPC.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Santa Maria da Boa Vista, data da assinatura eletrônica.

Tomás Cavalcanti Nunes Amorim

Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM
06/10/2025 12:51:03
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 218697458

25100612510390900000212855436

IMPRIMIR GERAR PDF